



Atualização HTLV – Pré Natal

Profa. Me. Daniele Matos de Moura Brasil



PROFE\$SORA DANI



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR



Qual a fonte dessa atualização, Prof.^a
Dani?



PROFE\$SORA DANI



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR



PORTARIA SECTICS/MS Nº 13, DE 3 DE ABRIL DE 2024: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sectics/ms-n-13-de-3-de-abril-de-2024-551933905>

DETECÇÃO PRÉ-NATAL de infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) 1/2 em gestantes: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2023/sociedade/20231228_resoc_443_deteccao-pre-natal_htlv-em-gestantes.pdf

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) (2022)



Os vírus HTLV 1 e 2 pertencem à família *Retroviridae*, sendo que a infecção não implica, necessariamente, o desenvolvimento de processos patogênicos. As vias de transmissão são a sexual, a parenteral e a vertical (gestação, parto ou aleitamento materno, principalmente)³⁰¹⁻³⁰³.

O HTLV está associado a doenças neurológicas, oftalmológicas e dermatológicas, assim como a leucemia/linfoma³⁰¹. Das pessoas infectadas pelo HTLV, aproximadamente 90% permanecerão assintomáticas ao longo de suas vidas. Essas pessoas mantêm uma rede de transmissão silenciosa pela via sexual, sanguínea e vertical.

O aleitamento materno é a principal forma de transmissão vertical da infecção, que ocorre em 20% a 30% dos lactentes amamentados por mães infectadas. O risco está associado a variáveis individuais, a exemplo do tempo de amamentação³⁰⁴. A transmissão intrauterina ou no período periparto ocorre em menos de 5% dos casos. A transmissão sexual é mais frequente do homem para a mulher, refletindo-se em maiores taxas da infecção entre mulheres³⁰⁵.

As recomendações para a prevenção da transmissão vertical são:

- › Uso de preservativo em todas as relações sexuais;
- › Oferta de redução de danos para pessoas que usam drogas injetáveis;
- › **Contraindicação à amamentação em mães vivendo com HTLV 1/2**, sendo sugerido o uso de inibidores de lactação e de fórmulas lácteas infantis^{301,305}.



PORTARIA SECTICS/MS Nº 13, DE 3 DE ABRIL DE 2024

Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o exame para detecção pré-natal de infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) 1/2 em gestantes.

Ref.: 25000.081124/2022-22.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DO COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea "c" do inciso I do art. 32 do Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, e tendo em vista o disposto nos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o exame para detecção pré-natal de infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) 1/2 em gestantes.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto nº 7.646, 21 de dezembro de 2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS.

Art. 3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: <https://www.gov.br/conitec/pt-br>.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Como a infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) é detectada no SUS?

O diagnóstico da infecção pelo HTLV é feito por meio de exames de sangue, classificados pelo tipo de resultado que oferecem. Os testes de triagem são capazes apenas de detectar a presença de anticorpos específicos contra o vírus, enquanto os testes de confirmação conseguem definir o tipo do HTLV que causou a infecção.

Os testes ELISA, que servem para triagem, assim como PCR e Western Blot (WB), para confirmação/definição do tipo do vírus, estão disponíveis no SUS, porém para outras indicações.



Tecnologia analisada: testes do tipo Elisa, Western Blot e PCR

Testes do tipo Elisa, WB e PCR são usados para testagem do HTLV. Embora todos sejam exames de sangue, possuem finalidades e utilizam métodos diferentes para alcançar o resultado. O ELISA consegue detectar anticorpos contra o vírus, mas não diferencia o tipo de HTLV, enquanto o WB e o PCR, além de detectarem, são capazes de dizer o tipo do vírus que causou a infecção. O ELISA é mais barato e mais rápido, enquanto o WB e o PCR, mais caros e demorados, devem ser utilizados apenas nos casos de resultado positivo, para confirmar a infecção, identificar o tipo do vírus e, com isso, favorecer a escolha do tratamento adequado.

A ampliação de uso desses testes, no SUS, para diagnosticar a infecção pelo HTLV 1 e 2 em gestantes no pré-natal foi demandada pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde (SVSA/MS). Para avaliar a eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário da ampliação, foi feita uma análise de evidências clínicas e econômicas.



Vejo vocês na lista dos aprovados!



PROFE\$SORA DANI



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR